PROJETO CULTURA DE SEGURANÇA
GRUPO NITRO | AULA #11



Via aérea: competência de toda a Odontologia.

O efeito dominó: o risco que nós mesmos provocamos.

Profa. Dra. Carla Gamba.

Este efeito dominó está na rotina clínica de toda a Odontologia, não apenas na sedação.

1. Sinais vitais não aferidos e estresse invisível
2. Uso irracional de anestésico local
3. SNC e variação hemodinâmica
4. Via aérea: engasgo e corpo estranho
5. Deterioração clínica imediata



Atherton et al., 1999 · Fukayama & Yagiela, 2006.



PEÇA 1 · SINAIS VITAIS E ESTRESSE

O estresse também é adrenalina.

A adrenalina plasmática sobe durante o procedimento.

Com anestesia eficaz, a resposta simpática é mínima.

Dois tubetes: efeito hemodinâmico menor que uma caminhada leve.

Taggart et al., 1976 · Cioffi et al., 1985 · Niwa et al., 2000.



PEÇA 2 · USO IRRACIONAL DE ANESTÉSICO LOCAL

A dose máxima é determinada pelo sal anestésico.

No paciente ASA II, coexistem dois limites: a dose do sal (reduzida) e a de adrenalina. Prevalece o mais restritivo (0,04 mg para cardiopatas).

Lidocaína 2% (1:100.000)	≈ 2,2 tubetes
Articaína 4% (1:100.000)	≈ 2,2 tubetes
Articaína 4% (1:200.000)	≈ 4,4 tubetes
Mepivacaína 3% (Sem vaso)	Toxicidade por volume ≈ 1,5x superior. A ausência de vasoconstritor não amplia a dose máxima.

Cannell, 1996 · Ucer et al., 2026 · Hashemi et al., 2016 · Seminario-Amez et al., 2021 · Guimaraes et al., 2021 · Laraghoit et al., 2009 · Chin et al., 2003 · Su et al., 2014.

O CENÁRIO: Implante · ASA II (hipertenso controlado) · 2 tubetes (1:100.000) · primeira fresa · dor.

No paciente sistemicamente comprometido, a dose máxima do sal anestésico também é reduzida.



Mais anestésico, sabendo que está próximo do limite?



Seguir com dor?



Interromper, com o leito cirúrgico exposto?

Qual é a sua alternativa?

Ucer et al., 2026 · Cannell, 1996 · Cioffi et al., 1985 · Dionne et al., 1984.



PEÇA 3 · SNC E HEMODINÂMICA

Qual peça caiu? (Palidez, inconciiência, bradicardia, hipotensão)

Reflexo vasovagal e síncope

A emergência mais frequente na cadeira.

Sobredosagem de anestésico local

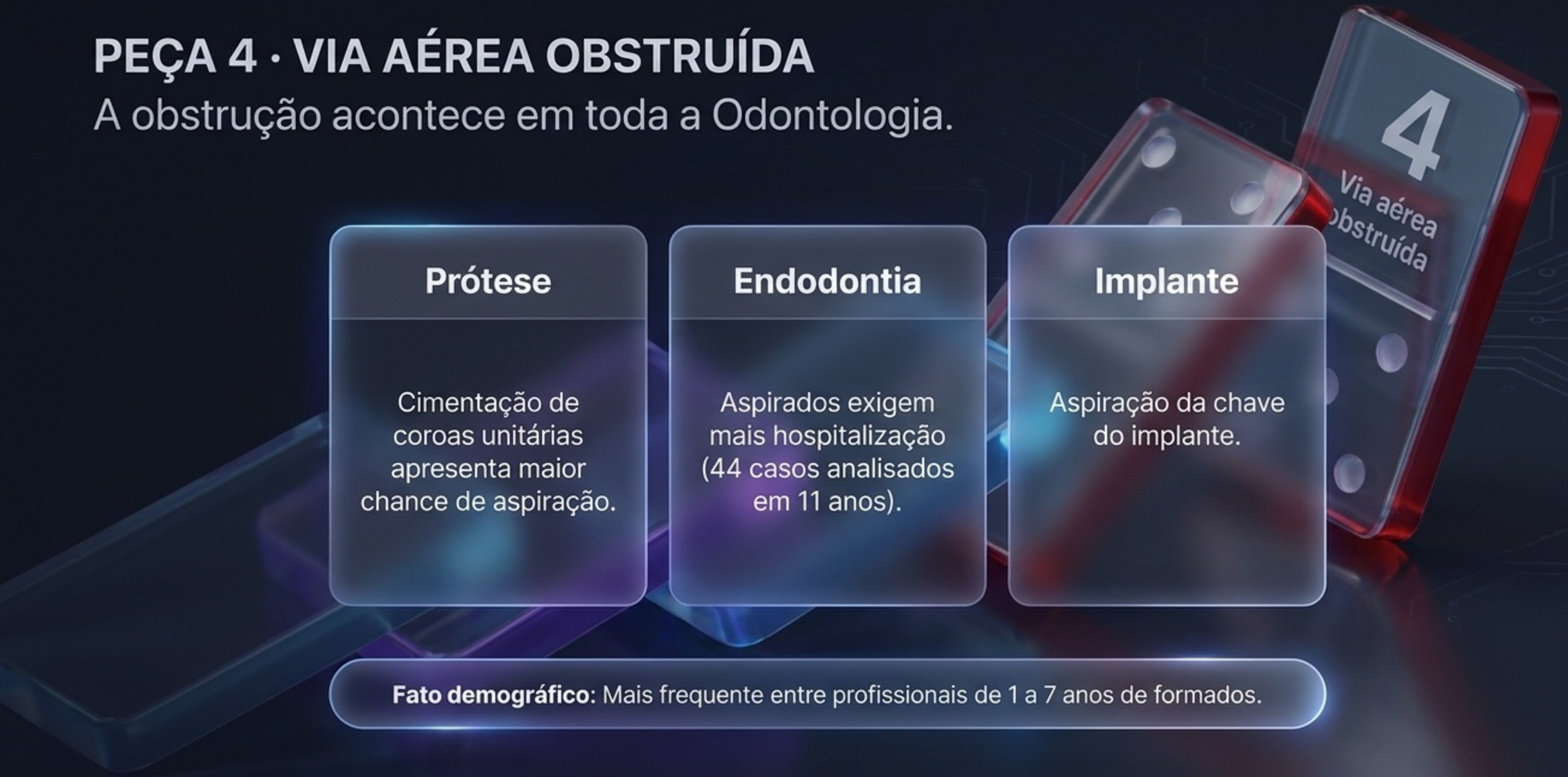
Da tontura à inconsciência, das arritmias à parada.

Só **40,5%** aferem a pressão. Até **87%** não calculam corretamente a dose.

Yamashita et al., 2025 · Rhee et al., 2019 · Otero et al., 2025 · Christensen & Shipp, 2026.

PEÇA 4 · VIA AÉREA OBSTRUÍDA

A obstrução acontece em toda a Odontologia.



Prótese

Cimentação de coroas unitárias apresenta maior chance de aspiração.

Endodontia

Aspirados exigem mais hospitalização (44 casos analisados em 11 anos).

Implante

Aspiração da chave do implante.

Fato demográfico: Mais frequente entre profissionais de 1 a 7 anos de formados.

Hisanaga et al., 2014 · Hou et al., 2016 · Tiwana et al., 2004 · Susini et al., 2007 · Araujo et al., 2021.

Ortodontia

1 em cada 5

ortodontistas já teve paciente que aspirou/ingeriu parte do aparelho.

· Componentes frequentemente envolvidos: Bandas, segmentos de fio e chaves de expansor.

Ingestão ou Aspiração?

Mais aspirados:

· Próteses (29%)

· Coroas (22%)

· Chaves de implante (17%)

Regra de Ouro: Componente perdido? Primeiro, descartar a via aérea. O silêncio não indica resolução: pode ser ausência de fluxo aéreo.

Varho et al., 2015 · Karamani et al., 2022 · Velapati et al., 2026.

PEÇA 5 · DETERIORAÇÃO CLÍNICA

A última peça.



1,4%
Eventos adversos ocorrem em cerca de 1,4% dos pacientes.

2/3
Ao menos dois terços terços são evitáveis.

42
Eventos graves (risco de vida) em ~1,28 milhão de atendimentos.

Causa mais comum: Falta de protocolo (Apenas 44,5% possuem protocolo de emergência estruturado).

Müller et al., 2008 · Tokede et al., 2024 · Lo et al., 2025 · Khattak et al., 2026.

O QUE SABEMOS, DE VERDADE

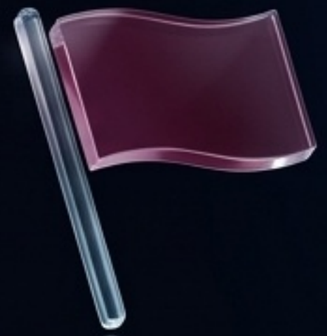
Saber não é o mesmo que conseguir fazer.



36% acertam a conduta na aspiração de corpo estranho.

82% não se sentem preparados para emergências.

Shaath et al., 2023 · de Aquino et al., 2026.



Red flag: a norma confirma a literatura

Plano de Segurança do Paciente no consultório (RDC 1002/2025 · ANVISA)

> O cirurgião-dentista deverá estar apto a prevenir, reconhecer, manejar e resgatar.

Resolução CFO 295/2026, art. 11, §1º.

NA SUA PRÓXIMA CONSULTA

Quatro atitudes indispensáveis.



4. **Aspiração eficaz:** Uso de alto volume (150 a 300 L/min) para fluxo contínuo.

2. **Investigar ronco e apneia:** Questionário STOP-Bang.

3. **Examinar a orofaringe:** Índice SARI (Avaliação rigorosa considerando seus 7 critérios formais: abertura bucal, mobilidade cervical, distância tireomentoniana, Mallampati, IMC, etc).

1. **Aferir a pressão arterial** (Registro sistêmico basal).

Holliday et al., 2021 · Graetz et al., 2022.

VIAS AÉREAS PARA TODA A ODONTOLOGIA

#11
Reconhecer o risco (Hoje)

#12
Prevenir
(Avaliação clínica)

#13
Manejar e resgatar
(SBV e SAVO)

Trilha 295 — Avaliação de vias aéreas, monitorização, SBV e SAVO no mesmo percurso, rumo à Habilitação.

Black Friday presencial (Rio) | Online 104h. Envie TRILHA no WhatsApp.

Nenhum curso habilita. Quem habilita é o Conselho.

“Na Odontologia, a cavidade oral é o nosso campo de trabalho, mas a via aérea é a nossa responsabilidade: o dominar sua anatomia e fisiologia é o que transforma o risco iminente e em segurança clínica.

Grupo NiTRo

Todas as referências estão na descrição desta aula.